

CENEOP

Centro Nacional de Estudios del Orden Público

FONDO REVALORIZADOR DE PENSIONES Y HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DE DIPRECA

Análisis jurídico-técnico actualizado y bases para un proyecto de ley en materia previsional y de salud del personal afiliado a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)

Autores

General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

Abogado, Magíster en Ciencia Política (mención Gobierno), Universidad de Chile
Miembro de Número de CENEOP
Past-President Cuerpo de Generales

General ® Hero Negrón Schlotterbach

Ingeniero en Administración de Empresas
Magíster en Gestión de Recursos Humanos
Past-Presidente de CENEOP

Santiago de Chile, septiembre de 2026

(Actualiza y reemplaza el documento de trabajo interno de 15 de abril de 2021 e incorpora, sistematizado en el capítulo V, el informe técnico «Homologación de Financiamiento del Sistema de Salud para DIPRECA», de septiembre de 2026, del General ® Hero Negrón Schlotterbach)

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO	3
II. ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO	3
III. MARCO NORMATIVO VIGENTE	5
A. Marco constitucional	5
B. Marco legal e infralegal	5
IV. ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO ACTUALIZADO: LA ASIMETRÍA ENTRE DIPRECA Y CAPREDENA.....	7
V. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD DE DIPRECA	8
A. Fuentes de financiamiento comparadas del sistema de salud chileno	8
B. La brecha de financiamiento de DIPRECA frente al estándar del 7%	9
C. El Fondo Revalorizador de Pensiones como fuente de holgura fiscal desaprovechada	10
D. La Pensión Garantizada Universal y los montepíos de CAPREDENA y DIPRECA	11
E. Propuesta técnica de homologación al 7%	11
VI. BASES DE CÁLCULO IMPONIBLES Y DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES SOBRE 60 UF	13
VII. CONCLUSIONES.....	14
VIII. BASES PARA UN PROYECTO DE LEY	15
Idea matriz	15
Fundamentos (síntesis para el Mensaje)	15
TÍTULO I. Homologación del financiamiento del sistema de salud de DIPRECA	16
TÍTULO II. Igualación de la edad de cesación de la cotización de retiro	17
TÍTULO III. Corrección de bases de cálculo impondibles y devolución de excedentes	18
Disposiciones transitorias	18
IX. VÍA DE TRAMITACIÓN Y RECOMENDACIONES	19

I. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO

CENEOP – Centro Nacional de Estudios del Orden Público presenta este estudio, que actualiza, sistematiza y perfecciona el trabajo de análisis desarrollado desde 2012-2013 por uno de los autores en torno al Fondo Revalorizador de Pensiones (en adelante, «FRP») y a la situación previsional y de salud del personal en retiro y montepiado afiliado a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

El presente documento reemplaza el memorándum interno de 15 de abril de 2021 y, en esta versión, incorpora y sistematiza el informe técnico «Homologación de Financiamiento del Sistema de Salud para DIPRECA» (septiembre de 2026), elaborado por el General[®] Hero Negrón Schlotterbach, que profundiza y actualiza con nuevos antecedentes cuantitativos y presupuestarios la propuesta de redestinación de recursos a salud contenida en la versión anterior de este estudio, sin alterar el diagnóstico histórico y jurídico ya construido por los autores.

El estudio persigue cinco objetivos: (i) reconstruir con precisión los antecedentes históricos y legislativos de la materia; (ii) actualizar el marco normativo aplicable a la luz de la Ley N° 21.735, de 2025, que estableció la reforma más profunda al sistema de pensiones chileno en las últimas cuatro décadas, y de la Ley N° 21.730, de 2025, que creó el Ministerio de Seguridad Pública; (iii) diagnosticar cuantitativamente la brecha de financiamiento del sistema de salud de DIPRECA frente al estándar de cotización del 7% vigente en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), en las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), formulando una propuesta técnica de homologación; (iv) formular, en términos técnicos y con fundamento legal expreso, las bases de un proyecto de ley que corrija las deficiencias detectadas; y (v) identificar la vía constitucionalmente idónea para su tramitación.

El estudio se centra en tres materias, íntimamente relacionadas entre sí por incidir todas en el régimen previsional y de salud del mismo colectivo de cotizantes y pensionados: (a) la homologación del financiamiento del sistema de salud de DIPRECA al estándar del 7% de cotización vigente en FONASA, las ISAPRES y el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y CAPREDENA, mediante la reestructuración de los fondos de medicina curativa, hospitalarios y de revalorización de pensiones que hoy financian, de manera asimétrica e insuficiente, la salud del personal activo, pensionado y montepiado de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el personal de planta de DIPRECA; (b) la igualación, sin distinción de sexo, de la edad de cesación de la cotización al Fondo de Retiro; y (c) la corrección de las bases de cálculo impositivas y la restitución de los excedentes cotizados sobre el tope de 60 UF.

II. ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO

La materia tiene su origen en la tramitación del Boletín N° 8.643-02, Mensaje del Ejecutivo de los años 2012-2013, que modificó diversos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile. Durante esa tramitación, el entonces General Director de Carabineros, don Fernando Cordero Rusque (Q.E.P.D.), el General Inspector don Iván González Jorquera

(Q.E.P.D.) y su asesor jurídico, uno de los autores del presente estudio, formularon indicaciones orientadas a corregir tres discriminaciones que, a su juicio, afectaban al personal afiliado a DIPRECA respecto del personal de Ejército, Armada y Fuerza Aérea:

- La eliminación de la cotización al Fondo de Retiro para los pensionados y montepiadas mayores de 65 años, que se traducían en una merma de sus ingresos líquidos.
- La igualación de esa edad entre hombres y mujeres, evitando que la exención operara a los 65 años para unos y a los 60 para otras.
- La redestinación a prestaciones de medicina curativa de DIPRECA de la cotización del personal activo con destino al Fondo Revalorizador de Pensiones que, a diferencia de lo que ocurre en las ramas de la Defensa Nacional, no se reincorpora hoy al financiamiento de la salud del personal de Carabineros.

La Ley N° 20.735, publicada el 12 de marzo de 2014, recogió parcialmente estas indicaciones: eliminó la cotización de retiro para los pensionados y montepiadas de CAPREDENA y DIPRECA mayores de 65 años. Sin embargo, no acogió la igualación etaria por sexo propuesta por los autores ni, sobre todo, la redestinación a la salud institucional de los recursos del Fondo Revalorizador de Pensiones, que quedó pendiente.

Entre 2014 y 2019 se desplegaron diversas gestiones para revertir esta situación: reuniones con el entonces Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera, con la Dirección de DIPRECA, con subsecretarios del ramo y con senadores y diputados. Se tuvo noticia de que la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, habría manifestado en su segundo mandato voluntad de impulsar la modificación conforme a sus atribuciones constitucionales, sin que ello llegara a materializarse por objeciones planteadas desde los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de la Mujer y la Equidad de Género, de Desarrollo Social y Familia, y de la Secretaría General de la Presidencia.

El 29 de enero de 2019, uno de los autores, en su calidad de Presidente del Cuerpo de Generales de Carabineros de Chile, remitió al Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera, una representación formal acompañada de un proyecto de articulado modificatorio de la Ley N° 15.386, del Decreto Ley N° 844, de 1975, y del Decreto Supremo N° 103, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional, en subsidio de la negativa a redestinar dichos recursos del FRP.

En la época de estas gestiones (2014-2019), Carabineros de Chile dependía del entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública, denominación histórica que se conserva aquí por fidelidad al relato. Como se explica en el capítulo III, dicha cartera fue posteriormente escindida por la Ley N° 21.730, publicada el 5 de febrero de 2025, de manera que las gestiones equivalentes deben dirigirse hoy al nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Entre 2019 y 2026 la materia no registró avances legislativos. Los sucesivos hechos de contingencia nacional -entre ellos el proceso constituyente y la pandemia de COVID-19- postergaron su tratamiento. Más recientemente, la Ley N° 21.735, de 26 de marzo de 2025, introdujo la reforma más significativa al sistema de pensiones chileno de las últimas décadas -incorporando un nuevo seguro social, aumentos de

cotización con cargo al empleador y ajustes a la Pensión Garantizada Universal-, pero excluyó expresamente de su ámbito de aplicación al régimen previsional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el que continúa regido por la Ley N° 15.386, el Decreto Ley N° 844, de 1975, y demás normas especiales analizadas en este estudio. El propio Ejecutivo señaló, durante la discusión de esa reforma, que no estaba contemplado abordar en ella el régimen previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Paralelamente, en septiembre de 2026 el General® Hero Negrón Schlotterbach elaboró el informe técnico «Homologación de Financiamiento del Sistema de Salud para DIPRECA», que actualiza con antecedentes presupuestarios oficiales del período 2020-2024 y con un análisis comparado de los estándares de cotización de salud vigentes en Chile el diagnóstico sobre la materia señalada en la letra (a) del capítulo I. Dicho informe, cuya autoría y responsabilidad técnica corresponden a su autor, se sistematiza íntegramente en el capítulo V de este estudio y sustenta el Título I del proyecto de ley que se propone en el capítulo VIII.

III. MARCO NORMATIVO VIGENTE

A. Marco constitucional

El fundamento constitucional de esta iniciativa descansa en las siguientes disposiciones de la Constitución Política de la República:

1. Artículo 19 N° 2°: la igualdad ante la ley y la proscripción de diferencias arbitrarias establecidas por el legislador, que constituye el fundamento sustantivo de la pretensión de igualar el tratamiento del personal de DIPRECA al de Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de salud, y de eliminar la distinción por sexo en la edad de cesación de la cotización de retiro.
2. Artículo 19 N° 9°: el derecho a la protección de la salud y el deber del Estado de garantizar el acceso a las acciones de recuperación, en cuya virtud se sustenta la exigencia de que las cotizaciones que hoy financian el Fondo Revalorizador de Pensiones sin retorno alguno para DIPRECA se reorienten a prestaciones efectivas de salud.
3. Artículo 19 N° 18°: el derecho a la seguridad social, cuya efectividad exige que las instituciones a cargo de administrarla -en este caso DIPRECA- cuenten con financiamiento suficiente y equitativamente distribuido.
4. Artículo 65, inciso cuarto, N° 6°: la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para «establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado». Esta norma es determinante para la estrategia de tramitación de las tres materias abordadas en este estudio -incluida la homologación del financiamiento del sistema de salud de DIPRECA analizada en el capítulo V- y se desarrolla en el capítulo IX.

5. Artículo 69: el principio de unidad de materia, que aconseja articular en un solo cuerpo normativo -y no en mociones dispersas- las tres materias abordadas en este estudio, por incidir todas en el mismo régimen previsional y en el mismo universo de beneficiarios.

B. Marco legal e infralegal

El régimen previsional y de salud del personal de Carabineros afiliado a DIPRECA se encuentra regulado, principalmente, por las siguientes normas, cuyo texto y numeración deben verificarse en su versión consolidada vigente antes de la presentación formal de la iniciativa, dado que algunas de ellas han sido objeto de modificaciones puntuales desde la última revisión de los autores, y dado que la articulación entre determinados cuerpos normativos -según se advierte expresamente más adelante en esta letra y en el capítulo V- requiere confirmación técnica por parte de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda:

- Ley N° 15.386, de 1963, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: crea y regula el Fondo Revalorizador de Pensiones (artículo 1°), fijando originalmente una cotización de cargo del personal activo y un aporte fiscal equivalente, su integración (artículo 3°) y el destino de sus recursos (artículo 11°).
- Ley N° 16.258, de 20 de mayo de 1965: crea la Comisión Revalorizadora de Pensiones de la Defensa Nacional y los Fondos de Revalorización de Pensiones y de Auxilio Social aplicables al personal del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. La articulación exacta de este cuerpo legal con la Ley N° 15.386 respecto del personal de Carabineros de Chile debe ser precisada por DIPRECA antes de la presentación formal de la iniciativa.
- Decreto Ley N° 844, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional: crea la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile; fija la cotización única del 8,5% y su distribución (artículo 9°), destinando de ella a lo menos un 30% al financiamiento de los beneficios médico, hospitalario y dental; las entradas ordinarias del organismo (artículo 20°); y la contabilización del Fondo de Retiro (artículo 24°).
- Decreto Supremo N° 103, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional: Reglamento Orgánico del Departamento de Previsión de Carabineros de Chile (artículo 34°, entradas ordinarias).
- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, del ex Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, y Decreto Ley N° 1.812, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional: regulan y crean, respectivamente, el Fondo Hospital del Imponente de DIPRECA (1% de las remuneraciones imponibles del personal activo y 2% de las pensiones de retiro y montepíos del personal pasivo).
- Decreto Supremo N° 509, de 1989 (publicado el 14 de febrero de 1990), del Ministerio de Defensa Nacional: Reglamento de Medicina Curativa de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (artículo 2°, que remite al 30% del descuento obligatorio del artículo 20°, letra a), del Decreto Ley N° 844).

- Decreto N° 412, de 1992: crea el Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile (artículo 4°), formado por un 1,5% de cotización del personal y un 1,5% de aporte de la institución empleadora, administrado por la Dirección de Salud de Carabineros de Chile. Su relación con el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, debe igualmente ser precisada por la institución.
- Decreto Ley N° 2.547, de 1979: establece, en su artículo 2°, el mecanismo de reajuste automático de las pensiones de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, antecedente relevante para el diagnóstico sobre la pérdida de vigencia funcional del Fondo Revalorizador de Pensiones que se desarrolla en el capítulo V.
- Ley N° 19.185, artículo 17°, y Ley N° 18.675, artículo 9°: fijan el carácter imponible de las asignaciones sustitutiva, profesional, de funciones críticas y de alta dirección pública.
- Ley N° 20.735, de 12 de marzo de 2014: eliminó la cotización al Fondo de Retiro para los pensionados y montepiadas de CAPREDENA y DIPRECA mayores de 65 años.
- Ley N° 21.735, de 26 de marzo de 2025, «Reforma de Pensiones»: reformó sustancialmente el sistema de pensiones basado en capitalización individual (nuevo Seguro Social, incremento de cotización de cargo del empleador, Pensión Garantizada Universal), excluyendo expresamente de su ámbito de aplicación al régimen previsional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Su artículo 13 bis dispone, en lo pertinente, que a los titulares exclusivos de pensiones de montepío de CAPREDENA y DIPRECA sin otra pensión no se les aplica la exclusión del artículo 33 de la Ley N° 20.255, de 2008, pudiendo acceder a la Pensión Garantizada Universal en los términos que se explican en el capítulo V.D.
- Ley N° 21.730, publicada el 5 de febrero de 2025: crea el Ministerio de Seguridad Pública, al que pasan a depender Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, antes bajo la tuición del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En consecuencia, las gestiones, oficios y comunicaciones que este estudio recomienda dirigir al Ejecutivo en materias relativas a Carabineros y a DIPRECA deben canalizarse, en lo sucesivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, sin perjuicio de la coordinación que corresponda con el Ministerio de Defensa Nacional en lo relativo al régimen previsional propiamente tal.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO ACTUALIZADO: LA ASIMETRÍA ENTRE DIPRECA Y CAPREDENA

El núcleo del problema identificado en 2013 y aún no resuelto es el siguiente: la cotización de cargo del personal de Carabineros en servicio activo destinada al Fondo Revalorizador de Pensiones no retorna, en parte alguna, a financiar prestaciones de salud del propio personal ni de sus cargas, a diferencia de lo que ocurre en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, instituciones en las que un porcentaje equivalente sí se reincorpora al financiamiento de sus respectivos regímenes de salud administrados por CAPREDENA.

Esta diferencia de trato se produce entre servidores públicos armados sujetos a regímenes previsionales estructuralmente análogos -todos ellos derivados del sistema de reparto propio de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública-, lo que exige, conforme al estándar del artículo 19 N° 2° de la Constitución, una justificación objetiva, razonable y proporcionada. En la revisión efectuada por los autores no se ha identificado una razón técnica o actuarial que justifique mantener esta asimetría entre DIPRECA y CAPREDENA; en su ausencia, la diferencia deviene arbitraria.

Un antecedente especialmente relevante para actualizar este análisis es que la Ley N° 21.735, de 2025, la reforma más profunda al sistema de pensiones chileno en cuarenta años, no modificó ni tuvo por objeto modificar el régimen previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden. El propio Ejecutivo declaró, durante su discusión, que dicho régimen quedaba fuera del proyecto. Ello significa que la vía de solución de la materia planteada en este estudio no ha sido ni será resuelta por esa reforma general, y que subsiste la necesidad de una iniciativa legal específica y acotada como la que aquí se propone.

En el debate público sostenido en años anteriores se han invocado, para justificar la inacción legislativa, consideraciones ajenas a la materia previsional -en particular, procesos judiciales y cuestionamientos institucionales derivados de hechos ocurridos con motivo de la crisis social iniciada en octubre de 2019-. Cualquiera sea el mérito de esas consideraciones en su propio ámbito de discusión, ellas no constituyen, a juicio de los autores, un fundamento jurídico idóneo para mantener una diferencia de trato en materia de salud respecto de los cotizantes y pensionados de DIPRECA, cuestión de naturaleza técnico-previsional y no disciplinaria o política.

Desde la perspectiva de la ciencia política, la persistencia de esta situación a través de gobiernos de distinto signo sugiere que el obstáculo no es doctrinario sino de economía política: la redestinación de recursos hoy inmovilizados en el Fondo Revalorizador de Pensiones compete, en la discusión presupuestaria, con otras prioridades sociales calificadas de mayor urgencia. Reconocer este hecho no debilita el fundamento jurídico de la propuesta, pero sí orienta la estrategia de tramitación hacia una vía que dimensione con precisión su costo fiscal y lo circunscriba a un universo acotado de beneficiarios, como se propone en el capítulo VIII.

El capítulo siguiente profundiza esta asimetría desde una perspectiva cuantitativa y presupuestaria, incorporando el diagnóstico técnico desarrollado por el General [®] Hero Negrón Schlotterbach, que dimensiona con precisión la brecha de financiamiento de salud de DIPRECA frente al estándar vigente en el resto del sistema de seguridad social chileno.

V. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD DE DIPRECA

El presente capítulo sistematiza e integra a este estudio el informe técnico «Homologación de Financiamiento del Sistema de Salud para DIPRECA» (septiembre de 2026), elaborado por el General [®] Hero Negrón Schlotterbach, cuyo diagnóstico cuantitativo confirma y profundiza, con antecedentes presupuestarios y comparados, la asimetría jurídica descrita en el capítulo IV.

A. Fuentes de financiamiento comparadas del sistema de salud chileno

El sistema de salud chileno contempla, esquemáticamente, cuatro grandes fuentes de financiamiento cuya comparación resulta indispensable para dimensionar la situación de DIPRECA:

- (i) El Fondo Nacional de Salud (FONASA), que recibe una cotización del 7% de las remuneraciones imponibles de sus afiliados, complementada con un aporte fiscal que representó aproximadamente un 77,8% del financiamiento total del organismo durante el año presupuestario 2025. Dicho aporte permite financiar, sin costo adicional para los afiliados de los tramos A, B, C y D, el copago cero en la Red de Salud Pública y las Garantías Explícitas en Salud (GES), que cubren 90 patologías.
- (ii) Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), financiadas con la misma cotización del 7% de sus afiliados, más los cobros adicionales por cargas familiares y médicas que cada plan contempla, sin aporte fiscal directo.
- (iii) El sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), estructurado sobre una cotización combinada equivalente al 7%, según el detalle siguiente:

Flujos de financiamiento FF.AA. y CAPREDENA	Personal activo	Pensionados y montepíos
Cotizaciones	5,5%	6%
Aporte fiscal	1,5%	1%
TOTAL	7%	7%

Cuadro 1. Flujos de financiamiento de salud de las Fuerzas Armadas y CAPREDENA

- (iv) El sistema de salud de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), que agrupa a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el personal de planta de la propia DIPRECA. A diferencia de los tres sistemas anteriores, el financiamiento de la salud de este colectivo se encuentra disgregado entre distintos fondos, con administración y bases de cálculo diferenciadas entre el personal activo y los pensionados y montepiados, según el siguiente detalle:

Fondo	Administración	Personal activo	Pensionados y montepíos
Fondo de Medicina Curativa	DIPRECA	2,55%	2,55%
Fondo Hospital del Imponente	Hospital del Imponente	1%	2%
Fondo para Hospitales — cotización	Dirección de Salud de Carabineros	1,5%	—

Fondo	Administración	Personal activo	Pensionados y montepíos
Fondo para Hospitales — aporte fiscal	Dirección de Salud de Carabineros	1,5%	—
TOTAL		6,55%	4,55%
Brecha frente al estándar del 7%		0,45%	2,45%

Cuadro 2. Flujos de financiamiento actuales del sistema de salud de DIPRECA

B. La brecha de financiamiento de DIPRECA frente al estándar del 7%

Del cuadro precedente se sigue que el financiamiento de salud del personal activo de DIPRECA alcanza actualmente a un 6,55% -2,55% del Fondo de Medicina Curativa, 1% del Fondo Hospital del Imponente y 3% (1,5% de cotización más 1,5% de aporte fiscal) del Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile-, y el de los pensionados y montepiados a un 4,55% -2,55% del Fondo de Medicina Curativa y 2% del Fondo Hospital del Imponente, sin acceso al Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile-. Ello arroja una brecha de 0,45 puntos porcentuales respecto del personal activo y de 2,45 puntos porcentuales respecto de los pensionados y montepiados, en ambos casos frente al estándar del 7% vigente en FONASA, las ISAPRES y el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y CAPREDENA.

Esta brecha adquiere particular relevancia porque, a diferencia de los afiliados a FONASA o a una ISAPRE, el personal y los pensionados de DIPRECA son cotizantes cautivos de su propio sistema de salud, sin posibilidad de optar por otro prestador o asegurador en condiciones equivalentes. A ello se agrega que, mientras los pensionados y montepiados de CAPREDENA reciben un aporte fiscal equivalente al 1% de sus pensiones y montepíos -según se refleja en el Cuadro 1-, los pensionados y montepiados de DIPRECA no cuentan con un aporte fiscal equivalente, lo que constituye una segunda manifestación, específica del ámbito de la salud, de la asimetría entre ambos regímenes ya identificada en el capítulo IV respecto del Fondo Revalorizador de Pensiones.

C. El Fondo Revalorizador de Pensiones como fuente de holgura fiscal desaprovechada

La Ley N° 15.386, de 1963, fijó originalmente, para el personal activo e imponente de las instituciones afectas al régimen de DIPRECA, una cotización de cargo del personal activo con destino al Fondo Revalorizador de Pensiones, complementada con un aporte fiscal equivalente, ambos orientados históricamente a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, financiar mecanismos de revalorización y atender pensiones mínimas, en un contexto previsional y social hoy superado.

El estudio de 2013 que dio origen a este trabajo, actualizado en el capítulo IV, identificó que dicha cotización equivale hoy, para el personal de Carabineros, a un 0,5% de la cotización única del 8,5% que establece el artículo 9° del Decreto Ley N° 844, de 1975. Esta cifra es distinta de los porcentajes de ejecución -de 0,96% a 0,62%- que exhibe el Cuadro 3: aquellos miden qué proporción de lo recaudado por

el Fondo Revalorizador de Pensiones se utiliza cada año, mientras que el 0,5% mide la parte de la cotización única del 8,5% que corresponde a dicho fondo, y no debe confundirse con ellos. Ni la forma exacta en que la Ley N° 15.386 y el Decreto Ley N° 844 se articulan entre sí, ni la base de cálculo precisa de ese 0,5%, han podido ser verificadas por los autores con las fuentes primarias disponibles para este estudio, por lo que ambas deben ser confirmadas por la propia DIPRECA antes de la presentación formal de la iniciativa, conforme a la prevención ya formulada en el capítulo III.B.

Ya en diciembre de 2012, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda advirtió, en su Diagnóstico del Sistema de Pensiones y otros Beneficios Pecuniarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que el mecanismo de revalorización de pensiones de CAPREDENA y DIPRECA había ido perdiendo vigencia a medida que se implementaban otros mecanismos automáticos de reajuste, en particular el establecido en el artículo 2° del Decreto Ley N° 2.547, de 1979, señalando la necesidad de un estudio en profundidad sobre la mantención de estos fondos. La Superintendencia de Seguridad Social se pronunció en un sentido convergente, mediante el Dictamen N° 13.288, de 2012, en el que analizó críticamente la permanencia del Fondo Revalorizador de Pensiones y señaló que su finalidad original había perdido una parte importante de su fundamento, recomendando estudiar la derogación de las disposiciones que mantienen vigente el mecanismo. No constan antecedentes de un estudio posterior que haya evaluado en profundidad la continuidad de estos descuentos.

La información oficial de ejecución presupuestaria de DIPRECA correspondiente al período 2020-2024, contenida en su Cuenta Pública 2025, confirma empíricamente este diagnóstico:

Año	Recaudación (M\$)	Utilización (M\$)	Ejecución	Excedente (M\$)	Excedente / recaudación
2020	15.026.851	143.643	0,96%	14.883.208	99,04%
2021	16.211.632	132.243	0,82%	16.079.389	99,18%
2022	15.987.781	126.525	0,79%	15.861.256	99,21%
2023	18.810.986	125.752	0,67%	18.685.234	99,33%
2024	18.934.045	118.314	0,62%	18.815.731	99,38%
Acumulado 2020-2024	84.971.295	646.477	0,76%*	84.324.818	99,24%*

Cuadro 3. Fondo Revalorizador de Pensiones DIPRECA: recaudación y utilización, 2020-2024 (M\$ = miles de pesos)

** En el acumulado, el porcentaje se calcula como utilización acumulada dividida por recaudación acumulada, y no como promedio simple de los porcentajes anuales. Los valores 2020-2024 corresponden a la serie publicada por DIPRECA en su Cuenta Pública 2025; la ejecución del año 2025 se encuentra pendiente de cierre y validación a la fecha de este estudio y no se incluye en el cuadro.*

Como se aprecia, la ejecución del Fondo Revalorizador de Pensiones de DIPRECA descendió sostenidamente de un 0,96% en 2020 a un 0,62% en 2024, pese a que la recaudación anual aumentó en el mismo período de \$15.027 millones a \$18.934 millones. En el quinquenio considerado se recaudaron

\$84.971 millones y se utilizaron solo \$646 millones, lo que arroja un excedente acumulado de \$84.325 millones, equivalente al 99,24% de lo recaudado. Esta cifra constituye, a juicio de los autores, el argumento técnico más sólido para sostener que la continuidad de una cotización cuyo destino histórico presenta una ejecución anual inferior al 1% no se encuentra hoy justificada, y que dichos recursos deben reorientarse al fortalecimiento del financiamiento de la salud de DIPRECA, en los términos que se proponen en la letra E siguiente y se articulan en el Título I del proyecto de ley del capítulo VIII.

D. La Pensión Garantizada Universal y los montepíos de CAPREDENA y DIPRECA

Un antecedente adicional, de menor incidencia directa sobre el financiamiento de la salud pero relevante para el diagnóstico previsional general de este colectivo, es que la Ley N° 21.735, de 2025, en su artículo 13 bis, dispuso que a los titulares exclusivos de pensiones de montepío de CAPREDENA y DIPRECA que no perciban otra pensión no se les aplica la exclusión establecida en el artículo 33 de la Ley N° 20.255, de 2008. En consecuencia, dichos montepiados pueden acceder a la Pensión Garantizada Universal si cumplen los demás requisitos generales, percibiendo un monto complementario cuando esta supere el valor de su montepío. Los autores dejan constancia de este avance parcial, introducido por la Reforma de Pensiones de 2025 pese a la exclusión general del régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de su ámbito de aplicación, y recomiendan su verificación y difusión entre los montepiados de DIPRECA, sin perjuicio de que esta materia no requiere modificación legal adicional y, por ello, no forma parte del articulado propuesto en el capítulo VIII.

E. Propuesta técnica de homologación al 7%

Sobre la base del diagnóstico precedente, el informe técnico que se sistematiza en este capítulo propone una reestructuración del financiamiento de salud de DIPRECA que permita alcanzar, tanto para el personal activo como para los pensionados y montepiados, el estándar del 7% vigente en el resto del sistema de seguridad social chileno, sin comprometer el Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile, cuya administración por la Dirección de Salud de Carabineros de Chile se estima adecuada y no requiere modificación. La propuesta se sustenta en tres medidas complementarias:

Primera. Suprimir la cotización de cargo del personal activo destinada al Fondo Revalorizador de Pensiones, con el consiguiente incremento de liquidez para dicho personal, y redestinar el aporte fiscal equivalente y los excedentes acumulados de dicho fondo al Fondo de Medicina Curativa de DIPRECA, conforme al diagnóstico de la letra C precedente.

Segunda. Incorporar al Fondo de Medicina Curativa de DIPRECA las cotizaciones que hoy financian el Fondo Hospital del Imponente -1% de las remuneraciones imponentes del personal activo y 2% de las pensiones de retiro y montepíos-, suprimiendo este último fondo como entidad separada.

Tercera. Incrementar en 0,45 puntos porcentuales la cotización de salud del personal activo y en 1,45 puntos porcentuales la de los pensionados y montepiados, de manera que, sumadas a las medidas anteriores, el Fondo de Medicina Curativa de DIPRECA quede financiado con una cotización del 4% de las

remuneraciones imponibles del personal activo y del 6% de las pensiones de retiro y montepíos, más un aporte fiscal del 1% sobre estas últimas.

Fondo	Administración	Personal activo	Pensionados y montepíos
Fondo de Medicina Curativa — cotización	DIPRECA	4%	6%
Fondo de Medicina Curativa — aporte fiscal	DIPRECA	—	1%
Fondo para Hospitales — cotización	Dirección de Salud de Carabineros	1,5%	—
Fondo para Hospitales — aporte fiscal	Dirección de Salud de Carabineros	1,5%	—
TOTAL		7%	7%

Cuadro 4. Flujos de financiamiento propuestos para el sistema de salud de DIPRECA

De este modo, el personal activo alcanzaría un financiamiento total de salud del 7% -4% de cotización al Fondo de Medicina Curativa más 1,5% de cotización y 1,5% de aporte fiscal al Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile-, y los pensionados y montepiados alcanzarían igualmente un 7% -6% de cotización más 1% de aporte fiscal al Fondo de Medicina Curativa-, equiparándose así al estándar vigente en FONASA, las ISAPRES y el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y CAPREDENA.

Norma	Artículo(s)	Contenido actual	Modificación propuesta
Ley N° 15.386, de 1963	Arts. 1°, 3° y 11°	Cotización de activos y aporte fiscal equivalente al Fondo Revalorizador de Pensiones	Suprimir la cotización de activos; redestinar el aporte fiscal y los excedentes acumulados al Fondo de Medicina Curativa DIPRECA
Decreto Ley N° 844, de 1975	Arts. 9° y 20°	Cotización única del 8,5%; a lo menos 30% (2,55%) destinado a medicina curativa	Fijar una cotización directa de 4% (activos) y 6% (pensionados) para el Fondo de Medicina Curativa
Decreto Ley N° 1.812, de 1977	Art. 1°	Fondo Hospital del Imponente: 1% activos / 2% pensionados	Suprimir el fondo; incorporar sus recursos al Fondo de Medicina Curativa
Decreto Supremo N° 509, de 1989	Art. 2°	Remite al 30% del art. 20°, letra a), del D.L. N° 844	Ajustar la remisión a la nueva cotización del art. 9° del D.L. N° 844
Decreto N° 412, de 1992	Art. 4°	Fondo para Hospitales de Carabineros: 1,5% cotización + 1,5% aporte fiscal, personal activo	Sin modificaciones
Decreto Supremo N° 103, de 1975	Art. 34°	Entradas ordinarias de DIPRECA	Ajuste formal de referencia, sin modificación sustantiva

Norma	Artículo(s)	Contenido actual	Modificación propuesta
Decreto Supremo N° 355, de 1990	—	Reglamento del Hospital DIPRECA; no contiene normas sobre cotizaciones	Sin modificaciones

Cuadro 5. Normas cuya modificación se propone para la homologación del financiamiento de salud de DIPRECA

Los autores destacan que la homologación propuesta no debe entenderse como un mero aumento de recursos disponibles, sino como una mejora efectiva y verificable de la protección de salud del personal activo, pensionado y montepiado de DIPRECA y de sus cargas familiares. Por ello, se recomienda que el proyecto de ley establezca expresamente que los mayores recursos que genere la homologación se destinen prioritariamente a: reducir los copagos; mejorar las coberturas; reducir o contener las primas del seguro complementario de salud; mejorar la protección frente a prestaciones de alto costo; y mejorar la oportunidad de la atención. Estos objetivos se recogen en el artículo pertinente del Título I del proyecto de ley que se propone en el capítulo VIII.

Los autores dejan finalmente constancia de que las cifras y referencias normativas contenidas en este capítulo provienen del informe técnico del General [®] Hero Negrón Schlotterbach y de la información presupuestaria pública de DIPRECA, y de que su correspondencia con la numeración vigente y consolidada de los cuerpos legales y reglamentarios citados, así como la exacta base de cálculo del aporte fiscal de la Ley N° 15.386, deben ser confirmadas por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda antes de la presentación formal de la iniciativa, sin que ello afecte la validez del diagnóstico ni de la propuesta de homologación aquí formulada.

VI. BASES DE CÁLCULO IMPONIBLES Y DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES SOBRE 60 UF

De manera independiente, pero conexas, a las materias analizadas en los capítulos IV y V, los autores han detectado que las bases de cálculo sobre las que se han determinado los descuentos previsionales y de salud del personal de DIPRECA -correspondientes al Fondo de Revalorización de Pensiones (artículo 11° de la Ley N° 15.386), al Fondo Hospital del Imponente (artículo 1°, letra a), del Decreto Ley N° 1.812, de 1977) y al Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile (artículo 4° del Decreto N° 412, de 1992)- se han determinado incorrectamente en numerosos casos, al omitirse la inclusión de las asignaciones sustitutiva, profesional, de funciones críticas y de alta dirección pública, las que, conforme al artículo 17° de la Ley N° 19.185 y al artículo 9° de la Ley N° 18.675, son imponibles.

Este error de base repercute, además, en los aportes patronales que, según el artículo 11° de la Ley N° 15.386 y el artículo 4° del citado Decreto N° 412, de 1992, deben efectuar los organismos empleadores, calculados sobre la misma base errónea.

La Contraloría General de la República se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la existencia de un tope de 60 UF para las remuneraciones y pensiones imponibles del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y sobre la consiguiente procedencia de restituir las cotizaciones enteradas en exceso

sobre dicho tope, en los Dictámenes N°s 50.751, de 2016; 42.701, de 2016; 17.457, de 2017; 35.603, de 2017; 6.324, de 2019, y 19.751, de 2019. Este criterio ha sido además validado judicialmente respecto de Gendarmería de Chile, en un fallo de la Corte Suprema que confirmó la aplicación del tope de 60 UF impositivos y la consiguiente procedencia de la devolución, precedente que resulta extensible por analogía a DIPRECA en tanto integrante del mismo sistema de pensiones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En consecuencia, corresponde en derecho que dichas bases de cálculo sean corregidas hacia el futuro y que los montos cotizados en exceso sean restituidos a los afectados, con los reajustes que correspondan, dentro de los plazos de prescripción aplicables a este tipo de obligaciones. El proyecto de ley que se propone en el capítulo VIII incorpora una norma expresa en tal sentido, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que individualmente puedan corresponder a los afectados con independencia de la tramitación legislativa.

VII. CONCLUSIONES

Del análisis precedente, los autores extraen las siguientes conclusiones:

Primera. El diagnóstico formulado en 2013 mantiene plena vigencia en su núcleo: el sistema de salud de DIPRECA se encuentra financiado, tanto para el personal activo como para los pensionados y montepiados, por debajo del estándar del 7% vigente en FONASA, las ISAPRES y el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y CAPREDENA, en un contexto en el que, adicionalmente, el 0,5% de la cotización única del 8,5% que corresponde conceptualmente al Fondo Revalorizador de Pensiones no se reincorpora, en parte alguna, a dichas prestaciones de salud.

Segunda. La Ley N° 20.735, de 2014, resolvió parcialmente el problema al eliminar la cotización de retiro para los pensionados y montepiados mayores de 65 años, pero dejó pendientes tanto la igualación etaria por sexo como la redestinación a salud de los recursos del Fondo Revalorizador de Pensiones.

Tercera. La Reforma de Pensiones de 2025 (Ley N° 21.735), pese a ser la modificación más profunda al sistema chileno en cuarenta años, excluyó expresamente el régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por lo que la materia planteada en este estudio no ha sido resuelta por esa vía y requiere una iniciativa legal específica. Su artículo 13 bis introdujo, con todo, un beneficio parcial en materia de Pensión Garantizada Universal para los montepiados exclusivos de CAPREDENA y DIPRECA, según se señaló en el capítulo V.D.

Cuarta. El diagnóstico técnico desarrollado en el capítulo V, sistematizado a partir del informe del General
® Hero Negrón Schlotterbach, cuantifica esta asimetría en una brecha de 0,45 puntos porcentuales respecto del personal activo y de 2,45 puntos porcentuales respecto de los pensionados y montepiados de DIPRECA, y demuestra, sobre la base de la ejecución presupuestaria oficial 2020-2024, que el Fondo Revalorizador de Pensiones ha operado con una ejecución anual inferior al 1% de lo recaudado, acumulando excedentes por \$84.325 millones en dicho quinquenio sin retorno alguno hacia prestaciones de salud. Estos antecedentes, corroborados por pronunciamientos previos de la Dirección de

Presupuestos (2012) y de la Superintendencia de Seguridad Social (Dictamen N° 13.288, de 2012), confirman que la continuidad del mecanismo en su diseño actual carece de justificación técnica suficiente y sustentan la propuesta de homologación formulada en el capítulo V.E.

Quinta. Persisten, de manera independiente y conexa, errores en la determinación de las bases imponibles y montos no restituidos por cotizaciones enteradas sobre el tope de 60 UF, respecto de los cuales existen dictámenes de Contraloría y un precedente judicial análogo referido a Gendarmería que respaldan la procedencia de su corrección y devolución.

Sexta. Por tratarse en su totalidad de materias de seguridad social -homologación del financiamiento de salud, exenciones previsionales y corrección de bases imponibles-, las modificaciones legales propuestas son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 65, inciso cuarto, N° 6°, de la Constitución. En consecuencia, la vía jurídicamente idónea no es la sola presentación de una moción parlamentaria, sino la elevación de una propuesta técnica -como la contenida en este estudio- para que sea acogida por el Ejecutivo mediante un Mensaje, o incorporada como indicación a una iniciativa presidencial en actual tramitación, sin perjuicio del respaldo político que puedan prestarle parlamentarios de las comisiones competentes.

Séptima. Las cifras, porcentajes y referencias normativas contenidas en el capítulo V, así como algunas de las contenidas en los capítulos III y VIII, deben ser confirmadas por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda antes de la presentación formal de la iniciativa, sin que ello afecte el mérito técnico ni jurídico del diagnóstico y de la propuesta de homologación formulados en este estudio.

VIII. BASES PARA UN PROYECTO DE LEY

Sobre la base de lo expuesto, CENEOP propone el siguiente articulado, concebido como bases técnicas para un futuro Mensaje Presidencial o para su incorporación como indicación sustitutiva a una iniciativa en tramitación, en los términos que se explican en el capítulo IX.

Idea matriz

«Modifica la Ley N° 15.386, el Decreto Ley N° 844, de 1975, el Decreto Ley N° 1.812, de 1977, y el Decreto Supremo N° 509, de 1989, del Ministerio de Defensa Nacional, para homologar el financiamiento del sistema de salud del personal afiliado a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile al estándar de cotización vigente en el Fondo Nacional de Salud, las Instituciones de Salud Previsional y el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional; igualar la edad de cesación de la cotización al Fondo de Retiro; y corregir las bases de cálculo de las cotizaciones previsionales y de salud del personal afiliado a dicho régimen.»

Fundamentos (síntesis para el Mensaje)

Los fundamentos desarrollados en los capítulos II a VII de este estudio -antecedentes históricos, marco normativo actualizado, análisis de la igualdad ante la ley, diagnóstico técnico de homologación del

financiamiento de salud de DIPRECA, situación de las bases imponibles y conclusiones- constituyen la motivación sustantiva de la iniciativa y deben incorporarse, en la extensión que se estime pertinente, en la parte considerativa del Mensaje o Moción que finalmente la contenga.

TÍTULO I. Homologación del financiamiento del sistema de salud de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 15.386, de 1963, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

1) Exceptúase a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y a las instituciones y personal afectos a su régimen previsional -Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el personal de planta de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile- de la cotización de cargo del personal en servicio activo destinada al Fondo Revalorizador de Pensiones, la que en lo sucesivo no les será exigible.

2) El aporte fiscal destinado al Fondo Revalorizador de Pensiones que corresponda, según su mecanismo de cálculo, a los pensionados y montepiados afiliados a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, le será enterado directamente a dicho organismo previsional y constituirá una de las entradas ordinarias descritas en el artículo 20° del Decreto Ley N° 844, de 1975, con destino exclusivo al financiamiento de prestaciones de medicina curativa.

3) Incorpórase el siguiente nuevo inciso penúltimo en el artículo 3°:

«Con todo, tratándose de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, los excedentes o remanentes acumulados a la fecha de entrada en vigencia de la ley que introdujo este inciso, aportados por ese organismo previsional al Fondo Revalorizador de Pensiones, le serán íntegramente restituidos por una sola vez y constituirán una entrada extraordinaria destinada exclusivamente a prestaciones de medicina curativa, en los términos que fije el reglamento respectivo.»

4) Incorpórase el siguiente nuevo inciso final en la letra c) del artículo 11°:

«Exceptúase del traspaso señalado en el inciso anterior a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, conforme a lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo 1° de la ley que modificó este cuerpo legal para homologar el financiamiento del sistema de salud de dicho organismo.»

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley N° 844, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional:

1) Reemplázase el inciso final del artículo 9° por el siguiente:

«Para el financiamiento de los beneficios médico, hospitalario y dental contemplados en el inciso anterior, el personal en servicio activo cotizará el 4% de sus remuneraciones imponibles y los pensionados de retiro y montepiados cotizarán el 6% de sus pensiones de retiro y montepíos, cotizaciones que se enterarán en el Fondo de Medicina Curativa de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, sin perjuicio del aporte fiscal a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 15.386

respecto de los pensionados y montepiados, y de las cotizaciones y el aporte fiscal destinados al Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile.»

2) Incorpóranse en el artículo 20°, a continuación de la letra b), las siguientes nuevas letras c) y d), pasando la actual letra c) y siguientes a ordenarse correlativamente:

«c) El aporte fiscal que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 15.386, se entere a favor de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile con destino al Fondo de Medicina Curativa. d) El remanente a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 3° de la Ley N° 15.386, con igual destino.»

3) Incorpórase en el artículo 24° un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final:

«Los dineros a que se refieren las letras c) y d) del artículo 20° se contabilizarán en una cuenta separada destinada exclusivamente al Fondo de Medicina Curativa, y su empleo se orientará prioritariamente a reducir los copagos, mejorar las coberturas, reducir o contener las primas del seguro complementario de salud, mejorar la protección frente a prestaciones de alto costo y mejorar la oportunidad de la atención del personal activo, pensionado y montepiado y de sus cargas familiares.»

Artículo 3°.- Derógase el Decreto Ley N° 1.812, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, que creó el Fondo Hospital del Imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, así como las disposiciones reglamentarias que lo desarrollan. Las cotizaciones que dicho fondo recibía se entienden, desde la entrada en vigencia de esta ley, comprendidas en la cotización de medicina curativa establecida en el artículo 9° del Decreto Ley N° 844, de 1975, según el texto fijado por el numeral 1) del artículo 2° de esta ley.

Artículo 4°.- Introdúcese la siguiente modificación en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 509, de 1989, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Medicina Curativa de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile: reemplázase la referencia a «a lo menos un 30% del total del descuento obligatorio a que se refiere la letra a) del artículo 20°» del Decreto Ley N° 844, de 1975, por una referencia a las cotizaciones y aportes establecidos en el artículo 9° de dicho decreto ley y en el artículo 1° de la Ley N° 15.386, conforme al texto que fijan las modificaciones introducidas por esta ley.

Artículo 5°.- Facúltase a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para verificar, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, la correspondencia de las cifras, porcentajes y referencias normativas contenidas en este Título con la numeración vigente y consolidada de los cuerpos legales y reglamentarios citados, y para proponer, por la vía reglamentaria que corresponda, los ajustes estrictamente formales que sean necesarios para su correcta aplicación, sin alterar el sentido, el alcance ni los porcentajes de homologación establecidos en los artículos precedentes.

TÍTULO II. Igualación de la edad de cesación de la cotización de retiro

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en las disposiciones de la Ley N° 20.735, de 2014, u otras que actualmente regulen la exención de la cotización al Fondo de Retiro del personal en retiro y montepío de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional:

- 1) Fíjase en sesenta años la edad a partir de la cual opera la exención de la cotización al Fondo de Retiro, sin distinción entre hombres y mujeres.
- 2) Reemplázase, en todas las disposiciones pertinentes, la expresión «sesenta y cinco años» referida a esta exención por la expresión «sesenta años», cuando dicha exención se aplique indistintamente a hombres y mujeres.

TÍTULO III. Corrección de bases de cálculo impositibles y devolución de excedentes

Artículo 7°.- Para todos los efectos de la Ley N° 15.386, del Decreto Ley N° 844, de 1975, y del Decreto N° 412, de 1992, son impositibles las asignaciones sustitutiva, profesional, de funciones críticas y de alta dirección pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley N° 19.185 y en el artículo 9° de la Ley N° 18.675.

Artículo 8°.- La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y los organismos empleadores respectivos deberán, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la entrada en vigencia de esta ley, recalcular las bases de cálculo de las cotizaciones y aportes a que se refiere el artículo anterior, y restituir a los afectados, reajustadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes en que se enteró cada cotización y el de su devolución, las sumas cotizadas en exceso sobre el tope de 60 unidades de fomento, conforme a los criterios establecidos en los Dictámenes N°s 50.751, de 2016; 42.701, de 2016; 17.457, de 2017; 35.603, de 2017; 6.324, de 2019, y 19.751, de 2019, de la Contraloría General de la República.

Artículo 9°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública. En los años siguientes se financiará con los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Disposiciones transitorias

Artículo primero transitorio.- Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- El incremento de las cotizaciones de salud establecido en el numeral 1) del artículo 2° de esta ley para el personal en servicio activo y para los pensionados y montepiados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile se aplicará en forma gradual, en los porcentajes y

plazos que determine el reglamento respectivo, el que no podrá exceder de treinta y seis meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo tercero transitorio.- La restitución del remanente acumulado del Fondo Revalorizador de Pensiones a que se refiere el numeral 3) del artículo 1° de esta ley se efectuará dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, sobre la base de la información financiera que para tal efecto certifique la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Artículo cuarto transitorio.- Las obligaciones de recálculo y restitución establecidas en el artículo 8° permanente deberán cumplirse conforme a un cronograma escalonado que el reglamento respectivo determinará, el que no podrá exceder de veinticuatro meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley.

IX. VÍA DE TRAMITACIÓN Y RECOMENDACIONES

Como se señaló en la conclusión sexta, las tres materias reguladas en el articulado propuesto - homologación del financiamiento de salud, exenciones previsionales y corrección de bases imponibles con devolución de excedentes- son todas ellas normas sobre seguridad social o que inciden en ella, en el sentido del artículo 65, inciso cuarto, N° 6°, de la Constitución Política de la República. Por esta razón, una moción parlamentaria que las contuviera directamente correría el riesgo de ser declarada inadmisibles por incidir en una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

En consecuencia, se recomienda la siguiente estrategia de tramitación, coherente con la experiencia ya reunida por los autores en sus gestiones de 2014 a 2019:

Primero: elevar este estudio, mediante oficio formal, a S.E. el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, solicitando que el articulado propuesto sea acogido mediante un Mensaje Presidencial o incorporado como indicación a una iniciativa legal en actual tramitación sobre materias previsionales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Segundo: gestionar en paralelo, ante las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado y de la Cámara de Diputados, el respaldo político de parlamentarios que puedan instar al Ejecutivo a hacer uso de su iniciativa exclusiva, acompañando este estudio como antecedente técnico.

Tercero: mantener contacto técnico con la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a efectos de validar las cifras del diagnóstico expuesto en el capítulo V y de afinar la estimación del costo fiscal del artículo 9° del proyecto, elemento que resulta determinante para la viabilidad presupuestaria de la propuesta de homologación, dado su mayor alcance respecto de la formulación contenida en la versión de 2021 de este estudio.

Firman el presente Informe en Derecho:

General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

Abogado, Cientista Político

Magíster en Ciencia Política (mención Gobierno), Universidad de Chile

Miembro de Número de CENEOP - Past-President Cuerpo de Generales

General ® Hero Negrón Schlotterbach

Ingeniero en Administración de Empresas

Magíster en Gestión de Recursos Humanos

Past-Presidente de CENEOP